

图 3-3-16 顺向型 AVRT

连续的快速规则的 QRS 波群，其形态和时限均正常，频率 200 次/分，未见明确 P 波。

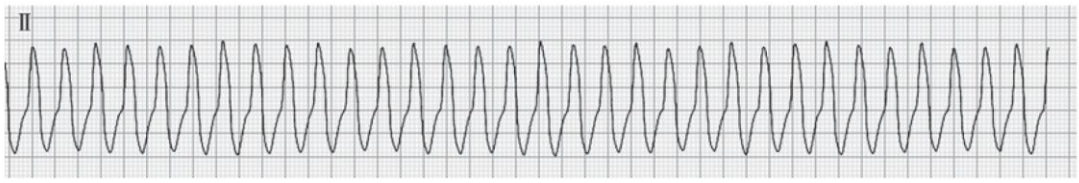


图 3-3-17 逆向型 AVRT

连续的、快速规则的 QRS 波群，QRS 波宽大畸形，QRS 波时间 0.13 秒，频率 214 次/分。

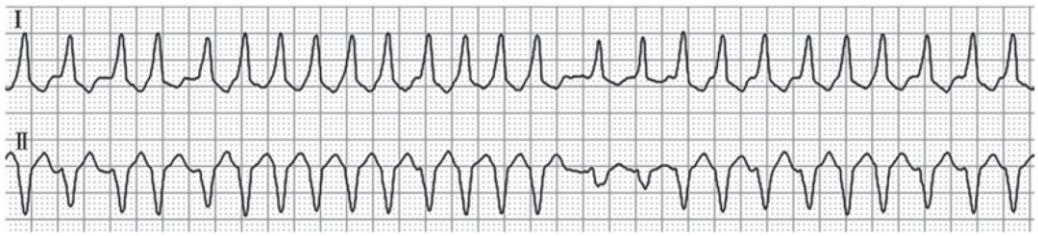


图 3-3-18 预激合并房颤

RR 间期不规则，QRS 波群形态多变，其起始部有预激波，心室率 201 次/分。

六、房早、交界早、阵发性室上性心动过速

（一）房早 正常人也有

1.多不治疗 若风湿病、冠心病、肺心病、甲亢导致的房早，治疗原发病即可
控心室率：β-R拮抗剂

2.心电图 心房异位起搏点提前激动心房

①提早出现房性 P'波，形态与窦性 P 波不同（山寨 P 波）冲动落到不应期导致左右心室除极出现一些差异

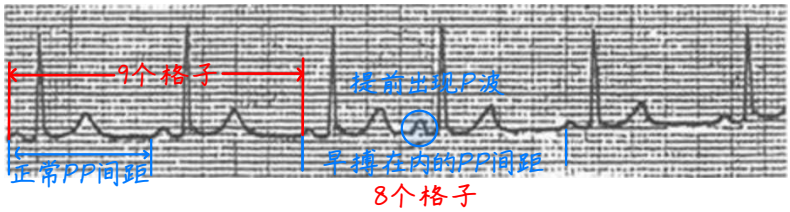
②P'波后多有 QRS 波、形态与正常 QRS 波多一致（除非发生室内差异性传导）

③P'波后也可无 QRS 波（房早未下传）恰好遇到房室结的不应期

④P'R 间期≥0.12s 房早基本走的慢路径所以P'R间期是超过某个值的
鉴别交界性早搏：P'R间期<0.12s

⑤房早后常出现不完全性代偿间隙（早搏在内的 PP 间距＜正常 PP 间距的 2 倍）

房早部位距窦房结较近，冲动会侵入窦房结，使其重新整合



《生理学》：在心肌 ERP 之后（相对不应期和超常期），下一次窦房结兴奋传来之前，心肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 ERP→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为什么那么巧？因为 ERP 长）→不会引起收缩（作废）→早搏后出现较长时间的舒张（代偿间歇）